UE B3 • S1 • CM15

De la prescription à l’administration

Responsabilité infirmière dans l’administration des traitements

Promotion 2026–2029 • Cours de Mme PILLON, septembre 2026 • 49 diapositives

MODE D’EMPLOI
Rouge = apprendre par cœur • Bleu = comprendre • Jaune = mémoriser • Vert = application en stage • Orange = vigilance / risque.

Objectifs du formateur

- Énumérer les étapes du circuit du médicament.
- Identifier la conformité d’une prescription.
- Distinguer les responsabilités de l’IDE.
- Préciser les modalités d’administration et les surveillances.

REPÈRE ESSENTIEL
L’IDE n’est pas un simple exécutant de la prescription : il vérifie, prépare si nécessaire, administre, surveille et trace. En cas de doute, il sollicite le prescripteur avant tout acte à risque.

Cadre du document. La progression suit les 49 diapositives : circuit, prescription, dispensation, stockage, administration, surveillance, erreurs et travail en collaboration. Les précisions réglementaires ont été vérifiées à partir des textes en vigueur au 15/10/2026. Les exemples sont pédagogiques, pas des ordres de prescription.

1 • Le circuit du médicament (diapos 3, 14–16, 26, 41)

Le circuit relie quatre étapes successives et interdépendantes. Les transports et le stockage assurent la continuité de la sécurité.

ÉTAPE	PROFESSIONNELS / ACTIONS	POINTS DE CONTRÔLE
1. Prescription	Prescripteur : évaluation, diagnostic, décision, ordonnance.	Indication, patient, médicament, dose, voie, rythme, durée.
2. Dispensation	Pharmacien : analyse pharmaceutique, préparation éventuelle, mise à disposition.	Interactions, contre-indications, disponibilité, traçabilité.
3. Administration	IDE ou professionnel habilité selon acte : vérifie, prépare, administre, trace.	Règle des 5 B ; allergies ; paramètres ; surveillance immédiate.
4. Suivi / réévaluation	Équipe soignante, médecin, pharmacien, patient.	Efficacité, effets indésirables, observance, adaptation.

BLEU • FIL CONDUCTEUR

Prescription → dispensation → transport / stockage → administration → surveillance / réévaluation. Si une étape est défaillante, la sécurité globale est menacée.

Officine et pharmacie à usage intérieur (PUI)

En officine : commandes, stockage, préparation et dispensation, puis gestion des déchets ; la pharmacovigilance accompagne le processus. À l’hôpital, la PUI assure les missions pharmaceutiques et participe à la sécurisation des prescriptions. Le livret thérapeutique répertorie les médicaments retenus dans l’établissement.

Quatre modalités de dispensation présentées par le cours

- Individuelle et nominative : médicaments délivrés pour un patient défini, selon une périodicité.
- Globalisée : médicaments fournis au service, qui organise ensuite la préparation.
- Réassort des dotations : réapprovisionnement de l’armoire du service.
- Rétrocession : délivrance par certaines PUI directement à un patient non hospitalisé, dans le cadre réglementaire.

VERT • EN STAGE

Demander où se trouve la PUI, comment les prescriptions sont validées, qui prépare les piluliers et comment les médicaments sont réapprovisionnés. Observer la chaîne du froid et le rangement des stupéfiants.

2 • La prescription médicale (diapos 4–13)

Une prescription est une décision thérapeutique formalisée. Elle peut concerner un médicament, un dispositif médical, un examen, des soins ou une prestation. Pour un médicament, elle doit fournir les informations permettant une administration sûre.

Qui peut prescrire ?

Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pédicures-podologues et infirmiers disposent de droits de prescription distincts et encadrés. Les vétérinaires prescrivent dans le domaine de la santé animale. Le droit dépend du champ de compétence et des textes applicables ; il n'est pas universel.

ROUGE • LES 4 FORMES D'ORDONNANCE DU COURS
Classique : manuscrite ou numérique, dans le cadre applicable.
Sécurisée : pour certaines prescriptions, notamment stupéfiants, avec exigences spécifiques.
Bizone : distingue soins liés à une affection de longue durée exonérante et autres soins.
Produits / médicaments d'exception : prescription sur support prévu pour leur prise en charge.

Mentions à vérifier avant l'administration

Prescription	Lecture IDE
Prescripteur et date	Identité, qualité et signature (ou validation électronique), date, possibilité de contact.
Patient	Identité complète concordante avec le dossier.
Médicament	DCI / nom, forme, dosage, posologie, voie, fréquence, horaires si utiles.
Durée	Durée du traitement, dates de début/fin ou critères d'arrêt si pertinents.
Conditions particulières	« Si besoin » : indication, dose, intervalle, limite quotidienne et surveillance ; adaptation selon protocole.

ORANGE • SI UNE MENTION MANQUE
Ne pas déduire une dose ou une voie « habituelle ». Faire clarifier la prescription, sécuriser la situation, informer l'équipe et tracer la démarche. Article R.4312-42 du CSP.

Prescription informatisée

Elle facilite la lisibilité, l'accès au dossier et les alertes, mais ne supprime pas les erreurs : mauvais patient sélectionné, doublon, prescription non actualisée, alerte ignorée, problème de synchronisation. Vérifier le dossier et les traitements actifs.

3 • Prescription IDE : évolution 2026 (diapos 5–6, 28–33)

Le cours rattache l'administration aux compétences de soins thérapeutiques et rappelle l'évolution du champ de prescription des infirmiers. Le cadre est établi notamment par le CSP et deux arrêtés distincts du 26 juin 2026.

TEXTE	À RETENIR
Arrêté du 20/02/2026, annexe II	Référentiel de certification : compétences 3 (réalisation des soins) et 4 (prescription) mentionnées dans le cours.
CSP art. R.4311-2	Missions infirmières : mise en œuvre, surveillance, conciliation médicamenteuse et prescription dans le domaine autorisé.
Arrêté du 26/06/2026 : prescriptions	Liste des produits / examens pouvant être prescrits ou renouvelés par l'IDE ; conditions et limites propres à chaque catégorie.
Arrêté du 26/06/2026 : actes et soins	Liste distincte des soins infirmiers et des actes pouvant être confiés à certains professionnels sous responsabilité infirmière.

Domaines de prescription IDE évoqués dans les diapositives

- Vaccination, avec conditions de formation / déclaration et recommandations applicables.
- Prévention et prise en charge des plaies.
- Santé sexuelle et reproductive : renouvellements encadrés, dont contraception orale sous conditions.
- Sevrage tabagique, certains produits de santé et examens biologiques / bactériologiques autorisés.

ORANGE • LA LISTE EST LIMITATIVE
Les catégories du cours ne constituent pas une autorisation de prescrire n'importe quel produit ou examen. Vérifier l'annexe exacte, l'âge, la situation, les conditions de renouvellement et de formation. La prescription IDE doit être inscrite au dossier patient / DMP (art. 2 de l'arrêté).

4 • Dispensation, transport et stockage (diapos 17–25)

Responsabilité du pharmacien

La dispensation comporte notamment l'analyse de la prescription et la mise à disposition des médicaments. La responsabilité pharmaceutique n'enlève pas à l'IDE son obligation de vérification au moment d'administrer.

Transport sécurisé

- Respecter les conditions de température : produits thermosensibles, chaîne du froid.
- Garantir la fermeture et la sécurisation des contenants et la rapidité des transports urgents.
- Acheminer rapidement les préparations à faible stabilité selon les règles de la PUI.

Stockage dans les services

- Stocks limités, armoires verrouillées, accès réservé aux professionnels habilités.
- Conserver emballage d'origine et informations d'identification, éviter chaleur, humidité et lumière inadaptées.
- Contrôler températures, péremptions et intégrité. Les stupéfiants exigent une gestion sécurisée.
- Séparer selon procédures : médicaments, dispositifs médicaux, produits inflammables et traitements personnels des patients.
- Ne pas mélanger médicaments et denrées alimentaires dans un même espace de stockage non adapté.

VERT • GESTES EN STAGE
Face à un produit périmé, sans étiquette, à chaîne du froid douteuse ou à un pilulier non identifiable : ne pas administrer, isoler si nécessaire et prévenir l'IDE / la pharmacie selon le protocole.

5 • Administration : rôle IDE (diapos 27, 34–40)

L'IDE réalise l'administration conformément au cadre légal et aux prescriptions / protocoles ; il exerce un jugement clinique à chaque étape. Les exemples « sur ordonnance » ne doivent jamais être confondus avec une exécution aveugle.

Avant : recueil et vérifications

- Identifier le patient par au moins deux identifiants appropriés ; vérifier allergies et antécédents.

- Lire la prescription active, vérifier indication, médicament, forme, dose, voie et heure.
- Évaluer l'état clinique pertinent : conscience, déglutition, tension artérielle, fréquence cardiaque, respiration, douleur, glycémie, bilan rénal/hépatique selon le médicament.
- Vérifier péremption, aspect, intégrité, dilution, compatibilité, voie et débit éventuels.
- Informer le patient ; rechercher accord et difficultés d'observance ; respecter les règles d'hygiène.

ROUGE • LES « 5 B » HAS
Bon patient • Bon médicament • Bonne dose • Bonne voie • Bon moment. Ce sont cinq objectifs de sécurité, à vérifier au moment pertinent, et non une simple récitation.

Pendant : administrer sans précipitation

- Limiter interruptions, préparer un patient à la fois si le protocole l'exige et sécuriser les étiquettes.
- Adapter la communication, la position du patient et le dispositif à la voie utilisée.
- Ne jamais écraser, couper, ouvrir ou mélanger une forme pharmaceutique sans compatibilité vérifiée.
- Utiliser une double vérification lorsque prévue pour des traitements à haut risque.

Après : tracer et surveiller

- Tracer au plus près de l'acte : médicament, dose, voie, heure, administrateur, omission / refus et motif.
- Réévaluer efficacité, tolérance et effets indésirables ; informer le médecin si nécessaire.
- Informer le patient sur l'objectif, les modalités et les signes devant être signalés.

ORANGE • UNE ABSENCE D'ADMINISTRATION SE TRACE AUSSI
Refus, vomissement, rupture de stock, contre-indication momentanée, omission, retard ou erreur : les documenter honnêtement et prévenir selon la gravité. Ne pas tracer un acte avant réalisation.

6 • Préparation et calculs de doses (diapos 39–40)

La préparation peut nécessiter un calcul de dose, une reconstitution, une dilution ou un débit. Tout calcul doit être rapproché de la prescription et de la concentration réellement disponible.

FORMULE	EXEMPLE PÉDAGOGIQUE
Volume (mL) = dose prescrite (mg) ÷ concentration (mg/mL)	Prescription 150 mg ; solution 50 mg/mL → 150 ÷ 50 = 3 mL.
Comprimés = dose prescrite ÷ dose par comprimé	Prescription 500 mg ; cp 250 mg → 2 comprimés, si forme fractionnable non nécessaire.
Débit (mL/h) = volume (mL) ÷ temps (h)	250 mL sur 5 h → 50 mL/h.

JAUNE • ASTUCE 3 QUESTIONS
1. Quelle est la dose prescrite ? 2. Quelle est la concentration réellement disponible ? 3. L'unité obtenue et le résultat sont-ils plausibles ?

ORANGE • MÉDICAMENTS À RISQUE
Vérifier protocoles et éventuelles doubles vérifications pour insuline, anticoagulants, opioïdes, électrolytes concentrés et autres médicaments à haut risque.
Un exemple de calcul ne permet jamais à lui seul de choisir un solvant, une vitesse ou une voie : consulter la prescription, le RCP et le protocole local.

7 • Surveillance clinique et réévaluation (diapos 41–43)

Le traitement doit être évalué dans le temps : réponse clinique, observance, effets indésirables, complications et conséquences sur le projet de soins. Le cours illustre une évaluation de l'observance en diapositive 43.

SURVEILLER	EXEMPLES DE DONNÉES ET ACTIONS
Efficacité	Douleur / EVA avant et après antalgique ; température sous antipyrétique ; glycémie sous insulinothérapie selon protocole.
Tolérance	Éruption, prurit, somnolence, malaise, hypotension, nausées, saignement, troubles respiratoires.
Paramètres vitaux	TA, FC, FR, SpO_2, température, conscience, selon le traitement et la situation.
Biologie pertinente	Glycémie, créatinine, kaliémie, INR et autres paramètres selon molécule / indication.
Observance	Compréhension, difficulté d'avaler, oubli, refus, effets gênants, capacité d'auto-administration.

Transmissions ciblées

Données : somnolence inhabituelle après prise. Actions : surveillance de l'état de conscience, constantes, appel médecin, sécurisation. Résultats : évolution et décision médicale tracées. Les faits doivent être mesurés et datés.

> VERT • MINI-SITUATION DE STAGE
> Un patient traité par antihypertenseur présente des vertiges avant la prise. Relever les constantes et symptômes, alerter l'IDE encadrant et demander réévaluation / clarification avant l'administration si les critères de sécurité l'exigent.

8 • Erreurs, risques et conduite à tenir (diapos 44–46)

Facteurs d'erreur relevés par le formateur

- Ordonnance incomplète, illisible ou comportant des abréviations ambiguës.
- Deux présentations très proches (« look alike »), mauvais dosage ou forme galénique.
- Prescription orale / téléphonique hors situation légalement justifiée.
- Déconditionnement prématuré et perte d'identification / date de péremption.
- Calcul erroné, interruption de tâche, confusion de patients ou mauvaise traçabilité.

> ROUGE • EN CAS D'ERREUR OU DE DOUTE
> Avant la prise : suspendre l'administration concernée, vérifier et faire clarifier la prescription.
> Après une erreur : évaluer et sécuriser immédiatement le patient, alerter l'IDE encadrant / le médecin selon urgence, surveiller, tracer les faits et effectuer la déclaration selon la procédure institutionnelle.
> Ne jamais cacher une erreur, ni modifier une trace pour masquer un événement.

Événement indésirable associé aux soins

Tout événement pouvant compromettre la sécurité doit être signalé selon le dispositif local ; les événements graves impliquent des obligations spécifiques de signalement. La pharmacovigilance porte sur la détection, l'évaluation et la prévention des effets indésirables médicamenteux.

Auto-administration par le patient

L’arrêté du 10 octobre 2022 a prévu la possibilité, avec accord du médecin et selon recommandations HAS, qu’un patient hospitalisé administre lui-même des médicaments prescrits. L’équipe évalue l’autonomie, informe, accompagne et assure une traçabilité adaptée. Ce n’est pas un transfert général de responsabilité.

9 • Travail en collaboration (diapos 47–48)

Le cours cite l’arrêté du 26 juin 2026 fixant la liste des actes et soins pouvant être réalisés par les IDE, et le CSP R.4311-5. Certains actes relevant du rôle propre peuvent être confiés sous responsabilité infirmière, après évaluation de la situation et en fonction de la qualification de la personne.

PEUT RELEVER DE LA COLLABORATION	NE PAS CONFONDRE
Aide à la prise des médicaments non injectables (AS / AP, dans les limites prévues).	Prescription, analyse clinique et administration d’un injectable ne deviennent pas des actes autonomes de l’AS.
Vérification de la prise, observation et transmission des difficultés.	Surveillance clinique, décision d’alerte, coordination et organisation relèvent du cadre infirmier.
Soins confiés après évaluation et consignes claires.	Une délégation n’est pas automatique : elle dépend du patient, du soin et des compétences du professionnel.

VERT • POUR UN ESI 1

Tu observes et participes sous l’encadrement de professionnels habilités, conformément aux objectifs de stage. Tu ne prends pas seul la décision d’administrer un médicament à risque ; tu signales tout doute avant d’agir.

10 • Lexique utile (diapo 48 enrichie)

ABRÉVIATION	SIGNIFICATION / INTÉRÊT
ALD / ANSM	Affection de longue durée / Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
CSP / CSS	Code de la santé publique / Code de la sécurité sociale.
DCI / DM / RCP	Dénomination commune internationale / Dispositif médical / Résumé des caractéristiques du produit.
EIG / EIAS	Événement indésirable grave / Événement indésirable associé aux soins.
FINESS / RPPS	Identification des établissements / Répertoire partagé des professionnels de santé.
IDE / IDEL / PUI	Infirmier diplômé d’État / IDE libéral / Pharmacie à usage intérieur.
LPPR / MTE	Liste des produits et prestations remboursables / Marge thérapeutique étroite.
NR / QSP / TA / FC	Non remboursable / Quantité suffisante pour / Tension artérielle / Fréquence cardiaque.
FR / SpO_2 / INR	Fréquence respiratoire / Saturation pulsée en oxygène / Rapport normalisé de coagulation.

11 • Quiz corrigé pour les partiels

1. Cite les 4 étapes principales du circuit.

Corrigé : Prescription, dispensation, administration, surveillance / réévaluation. Le transport et le stockage sont transversaux.

2. Quels sont les 5 B ?

Corrigé : Bon patient, bon médicament, bonne dose, bonne voie, bon moment.

3. Une dose paraît excessive. Quelle conduite ?

Corrigé : Ne pas administrer avant clarification ; vérifier auprès du prescripteur, alerter et tracer.

4. Que faut-il tracer après un refus de traitement ?

Corrigé : Médicament prévu, heure, refus et contexte, information du médecin / équipe, surveillance et suites.

5. Une solution contient 40 mg/mL ; prescription 120 mg. Volume ?

Corrigé : 120 ÷ 40 = 3 mL. Vérifier compatibilité et voie avant toute administration réelle.

6. Cite 3 surveillances pertinentes sous traitement.

Corrigé : Efficacité, tolérance / effets indésirables, paramètres vitaux et/ou biologie adaptés au traitement.

7. Un AS peut-il administrer tout traitement injectable ?

Corrigé : Non ; l'aide à la prise non injectable peut relever de collaboration selon conditions. L'injectable ne relève pas de cette aide.

8. Une prescription orale est-elle toujours interdite ?

Corrigé : Non : exceptions d'urgence prévues par le cadre applicable ; hors urgence, rechercher une prescription écrite conforme.

12 • Références vérifiées au 15/10/2026

Support principal : CM « De la prescription à l'administration », UE B3 S1, Mme PILLON, septembre 2026, 49 diapositives. Les autres références précisent le cadre réglementaire et les recommandations.

[1] Référentiel DE infirmier : arrêté 20 février 2026 et annexe II

[2] CSP : article R.4311-2 (missions infirmières)

[3] CSP : article R.4311-5 (collaboration)

[4] CSP : article R.4312-42 (prescription, doute, vigilance)

[5] Arrêté 26 juin 2026 : prescription IDE

[6] Arrêté 26 juin 2026 : liste des actes et soins

[7] Arrêté 6 avril 2011 : art. 13, circuit médicamenteux

[8] Arrêté 10 octobre 2022 : auto-administration

[9] HAS : Guide de sécurisation de l'administration, « 5 B »

> NOTE DE RIGUEUR
> La règle de formation / prescription est celle en vigueur à la date indiquée. Les procédures locales, RCP des médicaments et protocoles de service restent à consulter pour chaque administration réelle.

Responsabilité infirmière dans l’administration des traitements

Schéma de synthèse détaillé • construit à partir du cours associé

Prescription

Indication, patient, médicament, dose, voie, rythme et durée.

Dispensation

Analyse pharmaceutique et délivrance.

Administration

Contrôler, préparer, identifier, administrer dans le cadre applicable.

Suivi

Surveiller effets, tracer et transmettre; solliciter si doute.

Légende et repères d’application

1. Vérifier patient, médicament, dose, voie, horaire, allergies et cohérence de la prescription.
2. Se référer au produit, aux procédures et à la prescription; ne pas improviser une dilution.
3. La responsabilité IDE comprend vérification, administration, surveillance et traçabilité selon le cadre en vigueur.
4. En cas de doute ou de risque : suspendre la décision à risque et contacter le prescripteur / IDE encadrant.

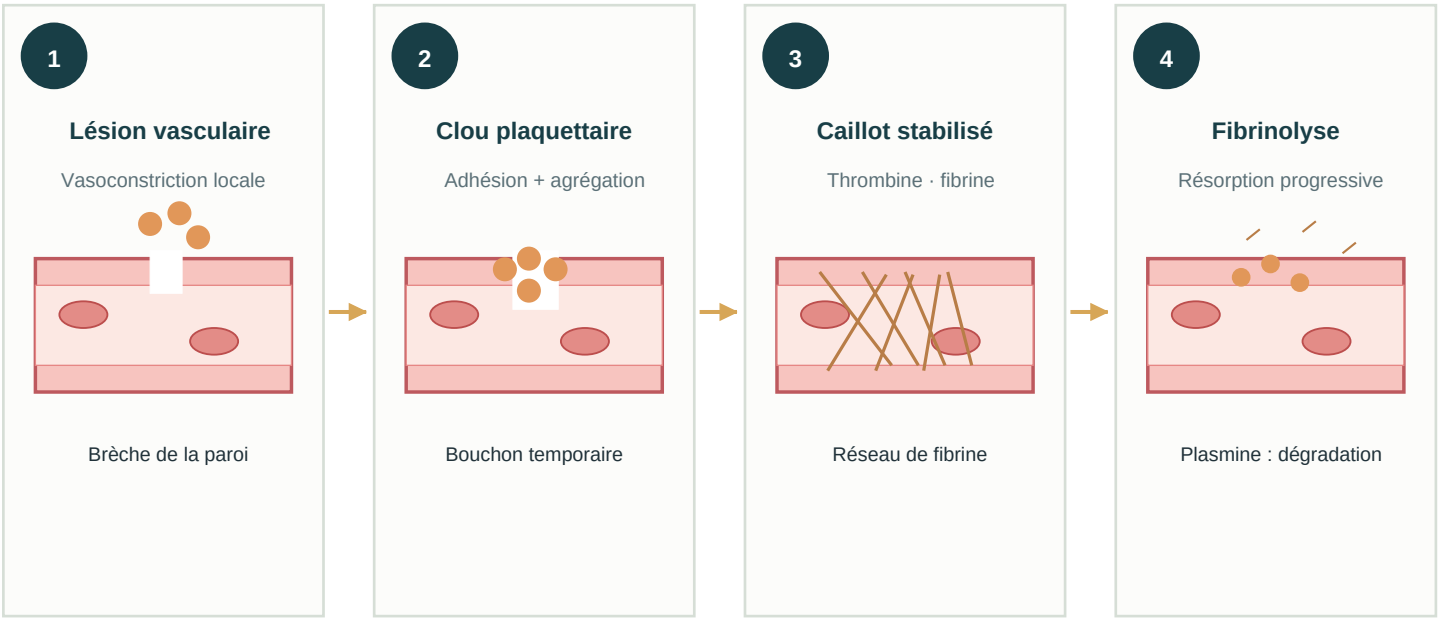
À retenir

Prescrire → dispenser → administrer → surveiller / tracer. Toute anomalie se clarifie avant l’acte.

Synthèse visuelle originale, fidèle aux notions du cours source. Utiliser les prescriptions et protocoles applicables.

Hémostase : colmater puis dissoudre

Repère visuel pour comprendre plaquettes, fibrine et lien avec le suivi biologique prescrit.



Deux temps complémentaires

Hémostase primaire : paroi + plaquettes · clou plaquettaire.

Coagulation : formation de fibrine · stabilisation du clou.

Puis fibrinolyse : la fibrine est progressivement dégradée.

Lien pratique pour l·IDE

TP/INR, TCA et autres bilans s·interprètent selon la prescription, le traitement, le laboratoire et le contexte clinique.

Surveiller les signes de saignement et transmettre une anomalie ou un signe clinique préoccupant sans attendre le seul chiffre.

Schéma simplifié · étapes biologiques chevauchantes. Source : Manuel MSD, Comment le sang coagule-t-il ? (consulté le 16/10/2026).